

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

NANCI APARECIDA TOLOSA DA SILVA

IDADE: 69a. PESO: 60 ALTURA: 159 PROFISSÃO: Balconista - Do lar
SINTOMAS: Sonolência Durante o dia / Fadiga mm.
QUEIXAS: Cansaço físico / Indisposição p/ levantar / Boca seca
MEDICAMENTOS: Vit B12 / Lisartana / Puvan T4 / Rosuvastatina
HAS / Colesterol ↑ / Hipotireoid. Vit D.
MÉDICO: Drº José Winston
MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N
EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 7 ALMOÇO: 12 LANCHE: 16 JANTAR: 20:30
HORA QUE DORME: 22h HORA QUE ACORDA:
COCHILLO (X) SIM () NÃO 30 DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 1 a 2x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 46.9 efl SPO2: 81%
med. 91%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA / HAS
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

12/04/24 Localização - Maracá N30

19/04/24 P= 9 cmH₂O melhora da sonolência
m. de uso: 7hr e disposição.
IAH= 13.2 efl
Fuga= 22. lpm. fua.

02/05/24 P= 9 cmH₂O * não está indo ao banheiro
m. de uso: 8h 10' 20: melhora da
IAH= 4.4 efl sonolência
fuga= 43.2 lpm. fua

05/06/24 P= 9 cmH₂O melhora da sonolência
m. de uso: 8hr não está levantando a
IAH= 0.5 efl noite.
Fuga= 24. fua.
TROCO O FILTRO.

10/07/24 P= 9 cmH₂O
IAH= 0.5 efl fua
Fuga= 24. lpm
m. de uso: 8hr.

15/10/24 P = 9 cm H₂O

IAH = 0,5 e/h

m de uso: 7h45

fuga: 24,4 l/m

Bem adaptada

Natasha

16/03/25 P = 9 cm H₂O

IAH = 0,5 e/h

m de uso: 7h36

fuga: 19,7 l/m

Bem adaptada

Natasha

20/03/25 P = 9 cm H₂O

IAH = 0,3 e/h

m de uso: 7h34

fuga: 28,6 l/m

Bem adaptada

Natasha

23/05 P = 9 cm H₂O

IAH = 0,5 e/h

m de uso: 8h

Bem adaptada, relata

que está roncando
baixo.

Nome: NANCY APARECIDA TOLOS
Sexo: F
IMC: 23.7
Idade: 68
Data de Ex:

COMENTÁRIOS:

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: NANCI APARECIDA TOLOSA DA SILVA			
Sexo: F	Idade: 69 anos	Peso: 60 Kg	Altura: 1.59 m
IMC: 23.7	Data do Exame: 06/03/2024	Exame: 13288_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:53:10 PM horas e encerrado às 6:01:17 AM horas, com latência para o sono de 1 minutos e latência para o sono REM de 273 minutos. O tempo total de sono foi de 416.0 minutos, com eficiência do sono de 96.6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.6%	Até 5%
Estágio 2	75.0%	45 - 55%
Estágio 3	9.3%	> 15%
Sono REM	14.2%	20 - 25%
Eficiência do sono	96.6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 13.5 minutos ocorreram **416 despertares (índice de 60.0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm , a maior de 75 bpm e a menor de 59 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 325 eventos respiratórios, sendo 0 central, 325 obstrutivos e 0 misto. Sendo 310 apnéias, 15 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 46.9/hora**, sendo 44.7 apnéia/hora e 2.2 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 26.2 e a duração máxima de 48.4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 96.6/hora, sendo 93.6 apnéia/hora e 3.1 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **93%**, sendo a **saturação média de 91%**, a **maior de 98%** e a **mínima de 81%**, permanecendo 70.7 minutos (16.4%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 327 dessaturações. Índice de dessaturações: 47.6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 97.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 40.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200